



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : جهاد مختار علي محمد
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : البساتين
رقم البطاقة : 28212110100925 رقم التليفون : 01220467577
العنوان : البساتين
العمر (تاريخ الميلاد) : 11-12-1982 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: جهاد مختار علي محمد National ID: 28212110100925	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

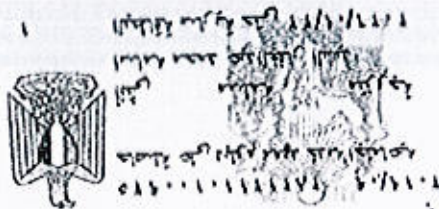
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient Name : جهاد مختار علي
Patient Info. : Male 43Y
Department : Out Clinic
Profile NO. : 3357-2023

Patient Id : 3457
VisitId : 5170
Collection Date : 04/12/2025 10:25:44
Reporting Date : 04/12/2025 10:56:16

Clinical Chemistry Report

<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Range</u>
<u>Kidney Function</u>			
Blood Urea	: 20.5	mg/dL	18.6 - 48
Serum Creatinine	: L 0.54	mg/dL	0.64 - 1.1
Calcium Ionized (Ca++)	: 1.18	mmol/L	N. 1.1 - 1.4

Signature

Dr. Sahar Mansour

Lab Test
[[DOCTYPE:LAB_TEST]]

Name: جهد مختار علي محمد		
MR. : 8244		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته تاريخ وساعة الدخول : تاريخ وساعة الخروج :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient was diagnosed with right-sided breast cancer, clinical stage T3 N1, with a hormone-receptor-positive, HER2-negative phenotype. Initial management included neoadjuvant chemotherapy (NAC) administered from 5 March 2024, followed by surgery (right breast conservation surgery) with pathology revealing ypT1 ypN0. Post-operative adjuvant therapy comprised zoledronic acid (Zometa), letrozole (Femara), and goserelin (Zoladex) initiated in June 2025. Follow-up imaging identified two solid lesions, prompting further evaluation and management planning. The current plan is continued surveillance and further work-up of the newly noted lesions.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	الطبيب المعالج : dina makram	
يعتمد ,		



MDT Form

1. Patient's Name: _____
2. Age: _____
3. Sex: _____

4. Date: _____
5. Time: _____

6. Ref: _____



PERSON OF INTEREST

DATE OF ONSET

15/01/2024

Clinical data

Hx: Work up
Plus free
ct chest free

Hx: 2 Hx

St15H

K107
33

Physical Examination

BX

10C

TR

8/8

PR

8/8

H

H1

H

M0

Immunohistochemistry

1. Breast UOQ palpable ill defined area of altered parenchymal echogenicity with ipsilateral indeterminate axillary lymphadenopathy (BIRADS 4a)
2. Breast (BIRADS 3) benign looking solid mass lesion

PATIENT HISTORY

RECEIVED RAC 1 ACx4 then Taxotere x 4 then BC5
YPTICHO

MDT OUTCOME & PLAN

1. ADJUVANT ZOLADEX FEMARA
2. PORT

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

PSYCHIATRY

SIGNATURE

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition



Patient Name : **Ms. Maryam Al-Fayez**
Patient No. : **28212110100925**
Path No. : **2817/23**
Sex : **Female**
Age : **40 Y**
Referring Doc :

Request No. : **13001159**
Request Date : **24/08/2023**
Verification Date : **04/09/2023**
Financial Category : **Out Patient**
Department : **Out Patient**
Registered by : **marwa mohamed youss**

Pathology Report

Clinical Data: Bilateral breast masses.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 23/8/2023, 10:25 am and 10:30 am

Gross Examination:

- 1- Right breast mass:
 - Five grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.
- 2- Left breast mass:
 - Four grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.
 - Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- Right breast mass:
 - Histological type: Invasive duct carcinoma with micropapillary features.
 - Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+1) Grade II.
 - Ductal carcinoma in situ: No.
 - Perineural invasion: No.
 - Angiolymphatic invasion: No.
 - IHC (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8).
 - PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8).
 - Her2: Faint incomplete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 1+).
 - Ki67: 35% nuclear reaction of tumor cells.

Left breast mass:
reveals a cores of breast tissue showing a benign growth made up of proliferating small patent mammary ducts. Some of the ducts are compressed and closed, other are patent. The

Verified by:
DR Menna Nabil

Printing Date: 04/09/2023 10:15:56

Page 1 of 1

Pathology Report

Patient Name : مروة محمد يوسف
 Patient No. : 28212110100925
 Path No. : 2817/23
 Sex : Female
 Age : 40 Y
 Referring Doc :

Request No. : 13001119
 Request Date : 24/03/2023
 Verification Date : 04/09/2023
 Financial Category : فئة مجانية
 Department : Out Patient
 Registered by : marwa mohamed youssef

Pathology Report

ducts are lined by inner columnar and outer myoepithelial cells. The stroma in between is formed of loose fibrous connective tissue. There is no evidence of malignancy in sections examined.

Diagnosis:
 Right breast mass, Tru-cut biopsy:
 Invasive duct carcinoma G II with micropapillary features.
 IFT:
 - ER: Positive (score 8/8).
 - PR: Positive (score 8/8).
 - Her2: (score 1+).
 - Ki67: Positive in 35 % of tumor cells.

Left breast mass, Tru-cut biopsy:
 Fibroadenoma.

Signature
 Prof. Dr. Lobna Omar.
 Dr. Menna Nabil.

Verified by :
 DR Menna Nabil

Printing Date : 01/09/2023 16:23.50

Page 2 of 2

Pathology Report



Name: Gehad Mokhtar
Date: 23-8-2024

Presidential Program for Women's health

Bilateral Breast Ultrasonography

Clinical summary: 40 years old with right breast palpable lump
Detailed Findings

Right breast

- Predominate fibroglandular parenchyma with mottling pattern
- UOQ palpable ill defined non mass area of hypoechoic altered parenchymal echogenicity with prominent ducts seen at 11:00-12:00 middle zone.
- Small well defined homogenous hypoechoic mass seen at 9:00 measuring 9x3.4mm
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Enlarged indeterminate axillary lymph nodes reaching 20mm in axis with diffuse cortical thickening reaches 6mm

LEFT breast

- Predominate fibroglandular parenchyma with mottling pattern
- Two well-defined adjacent hypoechoic solid mass lesion showing echogenic septation and gentle lobulations, seen at 12:00-1:00 together measured about 50x20mm.
- Another well-defined homogenous hypoechoic mass seen at 9:00 measured 17x4mm
- Few scattered tiny clear cysts are noted
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Conclusion:

Right breast: (BIRADS 4a) UOQ palpable ill-defined area of altered parenchymal echogenicity with ipsilateral indeterminate axillary lymphadenopathy. Biopsy was done to exclude malignancy
9:00 benign looking solid mass.
Left breast: (BIRADS 3) probably benign looking solid mass lesions as described. Biopsy was done from the large upper central one

Best Regards,

Dr. Eman All
Dr. Marwa M. Hassan

Patient Name: Gehad Mokhtar Ali Mohamed	Date: 04/09/2023
Exam:	Age: 40 Year(s)
Medical ID: 3357/2023	Pat ID: 41656

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST:

**** Newly discovered breast cancer:**

Findings:

- Left breast multiple irregular mass lesions are seen the largest measures about 3.5x 2.7 cm with enlarged left axillary lymph nodes, the largest measures about 2.7x 1.2 cm
- Right breast heterogenous parenchyma with irregular outer mass lesion measuring about 2x2 cm with enlarged right axillary lymph nodes, the largest measures about 2.5x 2 cm.
- Left basal and lingular fine atelectasis.
- No sizable pulmonary nodules, masses or cavitation
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Small bony island noted in the left humeral head otherwise, no sizable osseous lytic or sclerotic lesion in the scanned skeleton.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- No CT evidence of pulmonary deposits or pneumonia.

DR. MOHAMMED MAHDOUB

Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department